Nepal: insurgencia maoísta y Chitwan Valley Family Study

Scoping JMP · octubre 2026

Parte A. Evento y datos de violencia

Nota: WebFetch bloqueado; [V] = snippets de ~29 búsquedas (Nepali Times citando INSEC, INSEC, SATP, RRT/IRB, PMC, NSO/IHSN); [NV] = conocimiento previo o inferencia.

1. Cronología nacional

Episodio: 13 feb 1996 – 21 nov 2006 (CPA) [V]. Balance INSEC: 13.248 muertos (7.905 por el Estado, 5.343 por la otra parte) y 931 desaparecidos [V].

Año	Muertes (Estado / Maoístas)	Estatus	Hitos
1996	81 (59/22)	[V]	13 feb: inicio (Rolpa, Rukum, Sindhuli, Gorkha)
1997	48 (16/32)	[V]	Baja intensidad
1998	409 (334/75)	[V]	Operación Kilo Sierra II
1999	469 (328/141)	[V]	
2000	399 (180/219)	[V]	Expansión Mid-West/Far-West
2001	633 (243/390)	[V]	Jun: masacre palacio; 23 nov: ataques en 42 distritos; 26 nov: emergencia y despliegue del RNA
2002	4.648	[V]	Año más letal; ~1/4 en mayo
2003	≈1.500-1.900	[NV]	Alto el fuego 29 ene–27 ago; acumulado ene-2003: 7.383 [V]
2004	≈1.800-2.000	[NV]	Acumulado 26 dic 2004: 10.884 [V]
2005	1.524 (815/709)	[V]	1 feb: golpe real; 6 jun: Bandarmudhe; alto el fuego unilateral sep-dic
2006	≈800	[V parcial]	Abril: Jana Andolan II; 21 nov: CPA

Geografía: inicio y mayor intensidad en Mid-West (Rolpa, Rukum, Jajarkot, Salyan) [V]; 42+ distritos desde nov 2001 [V]; Do & Iyer (2010 JPR): más muertes en distritos pobres, montañosos y boscosos [V].

2. Chitwan

Fecha	Lugar	Incidente	Fuente
1996-2002	distrito	Solo 10 muertos por maoístas según ONG nepalí	[V] RRT
2002	Bharatpur	Soldado asesinado; 2 autobuses escolares quemados; bomba en fábrica	[V]
18 feb 2004	Jugedi (oeste)	2 insurgentes muertos	[V] SATP
mar 2004	Meghauli (oeste, área CVFS)	Bombas en el aeródromo	[V]
13 may 2004	Pakhibas	5 maoístas muertos	[V] SATP
8 ago 2004	Ratnanagar (este)	Policía herido	[V]
abr 2005	Dharmachowk, Bharatpur	Bomba hiere a escolares	[V]

Fecha	Lugar	Incidente	Fuente
6 jun 2005	Bandarmudhe, Madi (sur-este, fuera del área CVFS)	Autobús: 38 muertos, 72 heridos, 4 mueren después	[V]
1996-2006	carreteras Prithvi/Mahendra	Emboscadas y minas esporádicas	[V]

Conteos VDC de INSEC para Chitwan: no accesibles. Estimación: ~100-200 muertos en 10 años, intensidad baja-media ("medium-intensity armed conflict 2000-2006" según el CVFS) [V cita/NV cifra]. Bharatpur menos afectada que las aldeas periféricas [V]. En el CVFS, solo 15 de 151 vecindarios (9,9%) tuvieron ≥2 palizas a <1 km [V, Benjet et al. 2020].

3. Datasets con código subdistrital

- **INSEC Conflict Victims' Profile**: 13.248 muertos + 931 desaparecidos; campos (Joshi & Pyakurel 2015, Int. Interactions 41(3)): distrito y VDC, muerto/herido/desaparecido, circunstancias, afiliación, perpetrador; "censo, no muestra" [V]. Consulta pública online no confirmada [NV].
- Do & Iyer (2010): distrito-año, sin replicación localizada [V]. Valente (2014 WBER): INSEC por distrito [V]. Pivovarova & Swee (2015 WD): panel NLSS, cero efecto sobre escolaridad con EF individuales [V]. Menon & Rodgers: DHS 1996/2001/2006 [V].
- UCDP GED: Asia 1989-2014 incluye Nepal [V]; ACLED solo desde 2010 [V]; SATP centroide distrital [V].
- CVFS: eventos georreferenciados (palizas, bombas, tiroteos) con fecha y distancia a 151 vecindarios; Williams et al. 2012 Demography [V]. El único dato sub-VDC real.

4. Conflicto y primera infancia / salud mental

- Valente 2015 JHE: más abortos espontáneos con intensidad [V WP].
- **Benjet, Axinn et al. 2020 JAMA Netw Open**: CVFS, N=10.623; palizas ≥2 a <1 km elevan MDD solo en quienes eran niños (<11) al inicio: 12,69% vs 5,08% [V]. Axinn et al. 2023 (AUD): cohorte más joven OR 1,66 [V].
- **Tafesse (York CHE, WP 2024-25)**: DHS 2022 + INSEC por distrito/fecha; exposición in utero–6 años ↑ ansiedad, 4-6 años ↑ depresión [V]. **Ya cubre la ventana 0-6 a nivel nacional**; la partición 0-2 vs 3-5 con medida clínica o variación intradistrital no está hecha [NV].
- Kohrt et al. 2012 (prospectivo 2000->2007) [V]; Luitel 2013 [V].

5. Complementos nacionales

- NLSS: II (2003/04) 1.160 hogares panel; III (2010/11) 1.032 panel; IV (2022/23) 9.600 hogares, sin panel [V]. Sin salud mental [NV].
- DHS 2022: GAD-7/PHQ-9 en 15-49 (N=12.355) [V]. GPS de clusters [NV].
- NMHS 2020 (NHRC): N=15.088 (9.200 adultos, 5.888 adolescentes 13-17), MINI 7.0.2, 7 provincias, representativa provincial [V]. Microdatos: pedir a NHRC [NV].

6. Veredicto

Variación intra-Chitwan escasa (~10% de vecindarios con exposición alta, sin masacre en el área CVFS) y ya explotada por Benjet 2020/Axinn 2023 con edad al inicio. Un corte 0-2 vs 3-5 en CVFS tendría unos cientos de niños expuestos. Estrategia: CVFS para mecanismos; DHS 2022 o NMHS

2020 × INSEC distrito-mes para identificación, diferenciándose de Tafesse con variación mensual, ventana 0-2 vs 3-5, microdatos VDC de Joshi & Pyakurel y resultados clínicos (MINI).

Factibilidad: 5/10 solo con CVFS; 6-7/10 híbrido. Killers: sin conteos VDC públicos; Tafesse ocupa DHS-2022 × INSEC; Benjet ocupa CVFS × edad; NMHS sin microdatos confirmados y sin panel NLSS-IV.

Parte B. Verificación del CVFS

Advertencia: toda descarga directa fue bloqueada por el proxy. [V] = fragmentos de búsqueda (ICPSR/DSDR, PMC, Ford School, prensa nepalí); [NV] = no verificado o inferido. 24 búsquedas.

1. Diseño del CVFS

- Línea base: muestra multietapa representativa del oeste de Chitwan en 1995; historias de vecindario (1995) y entrevistas individuales con calendario de historia de vida en 1996 a 5.271 personas de 15-59 [V]. ICPSR titula la colección "1995-2019" [V].
- Vecindarios: ICPSR documenta 171 vecindarios y 1.805 hogares [V]; los papers de salud mental hablan de 151 [V]; reconciliación [NV].
- Household Registry: registro demográfico mensual (nacimientos, defunciones, matrimonios, migración/residencia) [V parcial]; versión "126 meses" liberada en 2010, consistente con inicio en 1997 [V indirecto]; "más de 25 años" y seguimiento de todos los migrantes [V].
- Refrescos 2008 y 2016 [V]. ICPSR 4538 V22 (oct-2024), 1995-2019; incluye salud infantil y madres 2016 y 2019, encuesta escolar 2019 con test scores, y 14 datasets restringidos nuevos [V]. PIs: Axinn, Ghimire, Smoller [V].

2. Estudio de salud mental

- Campo 2016-2018; 10.714 entrevistados de 15-59, respuesta 93% [V]. WMH-CIDI 3.0 adaptado + calendario de historia de vida para fechar episodios; validado contra SCID [V].
- Trastornos: MDE, manía, pánico, PTSD, GAD, IED, alcohol; vida y 12 meses [V]. MDD vida 15,1% [V]. Edad de inicio: sí [V].
- Exposición al conflicto: exposición personal a palizas y exposición comunitaria georreferenciada (palizas a <1 km, 2000-2006, con fecha) [V]. Bombas/tiroteos [NV].
- Nacidos 1990-2006 con CIDI: solo nacidos ~1957-2003 eran elegibles. Nacidos 2004-2006 no tienen CIDI. Estimación: ~3.200-3.800 nacidos 1990-2003 [NV].

3. Otros resultados

Matrimonio, fecundidad, migración, trabajo, salud infantil, educación [V]. Residencia mensual 1997-2006 vía registro: en principio sí [V indirecto]; georreferencia de vecindarios restringida [NV].

4. Datos de conflicto

- INSEC 1996-2006: 13.248 muertos (7.905 por el Estado, 5.343 por otros) y 931 desaparecidos [V]. Joshi & Pyakurel (2015, International Interactions): censo de víctimas con distrito, VDC, perpetrador, tipo [V]; fecha [NV]; descarga abierta no encontrada [V]. Do & Iyer (2010 JPR): muertes por distrito [V].
- Muertos en Chitwan [NV]. UCDP GED cubre Nepal [NV]; ACLED Nepal desde 2010 [NV].

- Variación intra-Chitwan: el CVFS tiene eventos georreferenciados por vecindario (≥2 palizas a <1 km) [V]; Bharatpur/Narayangadh menos afectado que aldeas periféricas [V]. Bandarmudhe/Madi: 6-6-2005, 38-39 muertos [V].

5. Literatura

Williams et al. 2012 Demography; Bohra-Mishra & Massey 2011 Demography; Axinn, Ghimire, Williams, Scott 2013 JHSB; Axinn et al. 2022 JAMA Psychiatry; **Benjet et al. 2020 JAMA Netw Open (10.623 en 151 vecindarios; niños <11 al inicio del conflicto vs ≥11; ≥2 palizas <1 km -> incidencia MDD 12,69% vs 5,08%)**; Bruffaerts et al. 2024 Addiction (AUD) [todos V]. Diseño 0-2 vs 3-5: no hecho; solo corte <11/≥11 [V]. Tafesse (York, 2024) con DHS 2022: exposición in utero-6 años y ansiedad [V abstract].

6. Acceso

ICPSR 4538 parte pública, parte restringida [V]. Los datos CIDI 2016-18 no aparecen en la lista V22 -> probablemente solo por colaboración con Axinn/Ghimire [NV].

7. Componentes

Componente	Años	N	Variables	Acceso
Historias de vecindario	1995	171	contexto	ICPSR público
Entrevista individual + LHC	1996	5.271	matrimonio, fecundidad, educación, trabajo	ICPSR público
Household Registry mensual	1997-	1.805 hogares	residencia, nacimientos, muertes, migración	público + restringido
Olas / refresco	2008, 2016	[NV]	panel 1996-2008	ICPSR
Salud mental WMH-CIDI	2016-18	10.714	MDD, PTSD, GAD, pánico, IED, alcohol, edad de inicio	colaboración [NV]
Eventos violentos georreferenciados	2000-06	palizas	fecha, distancia	restringido/colaboración [NV]
Salud infantil y madres	2016, 2019	[NV]	antropometría	ICPSR
Encuesta escolar	2019	[NV]	test scores	ICPSR
INSEC / Joshi-Pyakurel	1996-2006	13.248 muertos	distrito, aldea, perpetrador	solicitar [NV]

8. Veredicto: 4/10 como JMP independiente

- N: nacidos 1990-2003 con CIDI ≈3.200-3.800; in utero/0-2 (1999-2003) ≈1.000-1.300; 3-5 (1996-98) ≈700-900; escolar ≈1.500. Expuestos a ≥2 palizas <1 km quizá un tercio [NV].
- Killers: (i) CIDI y georreferencias no públicos: depende de colaborar con el equipo CVFS, que ya publicó el ángulo niñez vs adultez para MDD (2020) y AUD (2024) y tiene PTSD en cartera; (ii) un solo distrito y variación de intensidad baja/moderada, medida como palizas; (iii) salida de Chitwan antes de 1997 no observable; (iv) CIDI 13-20 años después con recuerdo retrospectivo; (v) bins 0-2 vs 3-5 con cohortes muy estrechas -> poder limitado.
- Viable y nuevo: outcomes económicos (educación, trabajo, migración, matrimonio) por bin fino de edad con el registro mensual público + eventos INSEC/VDC; CIDI como extensión si hay acceso.